Tendofit®

Saúde e recuperação dos tendões

PRIMACÊUTICA

Distribuição: NOVAERA HOMEOPATIA · MANIPULAÇÃO

Dose: 300-600 mg / dia

Complexo Patenteado – Formulação Única

Para saúde e recuperação dos tendões

LESÃO NOS TENDÕES

- A mais comum lesão nos tecidos moles
- Prevalência: 5% da população sedentária e 30-50% dos atletas
- Aumento expressivo nas últimas décadas

Ex.: ruptura tendão de aquiles: 8x mais que nos últimos 20 anos

Esportistas e atletas
Ocupações de trabalho repetitivo

Lesões do tendão

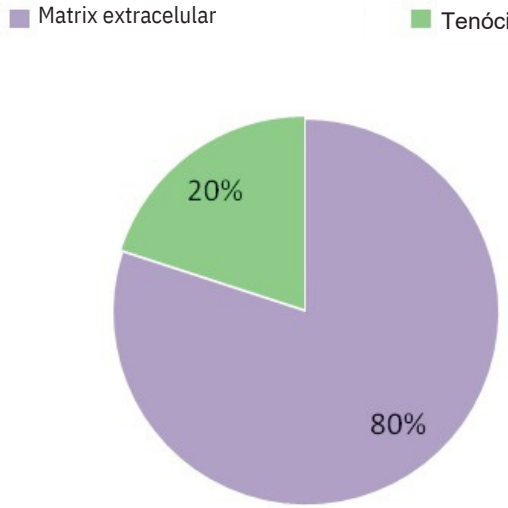
Tendinopatias podem ocorrer em quase todos os tendões

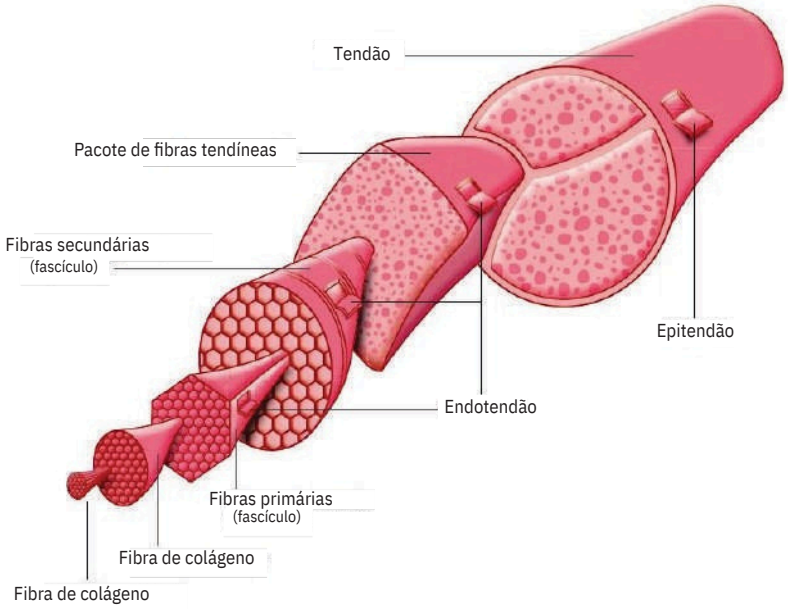
11.5573-5000
www.primaceutica.com.br

Estrutura tendões

Tendões são tecidos moles que conectam o músculo ao osso e confere resistência à tração, sendo de extrema importância para realização dos movimentos.

Composição dos Tendões





Matrix extracelular consiste:

- Água
- Colágeno tipo I
- Proteoglicanas e glicoproteínas

tendofit®

Contém :

- Mucopolissacarídeos
- Colágeno tipo I

→ **Componentes estruturais dos tendões**

Mecanismo ação

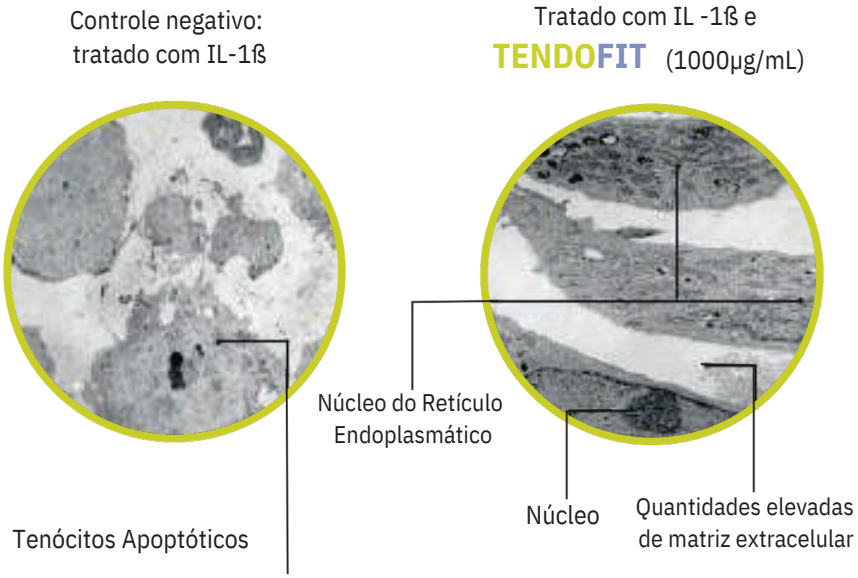
- Alívio da dor e recuperação da estrutura dos tendões
- Regulação da homeostase dos tenócitos
- Estimulação da síntese endógena de colágeno tipo I
- Diminuição de alterações degenerativas nos tendões

Benefícios clínicos

ÿ Promove recuperação da estrutura do tendão
ÿ Alívio da dor e melhora funcional do tendão
ÿ Reduz tempo de recuperação

Evidências científicas

Neutralização da degeneração do tendão



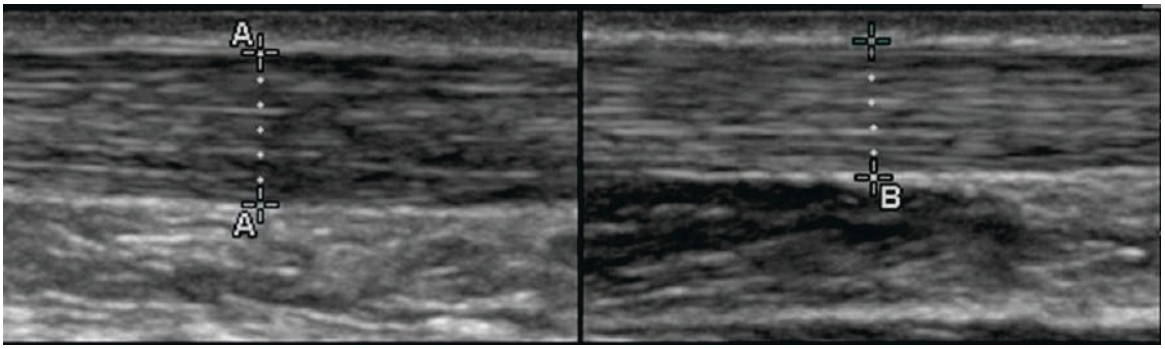
Shakibaei et al. Histology and Histopathology 2011; 26: 1173-1185

TENDOFIT® neutraliza os efeitos catabólicos de IL-1 nos tenócitos, promovendo proliferação e viabilidade celular.

Evidências científicas

Recuperação da estrutura do tendão

Imagem de ultrasom do tendão na linha de base e após tratamento com **Tendofit®**



Linha de base ø=0.67 cm

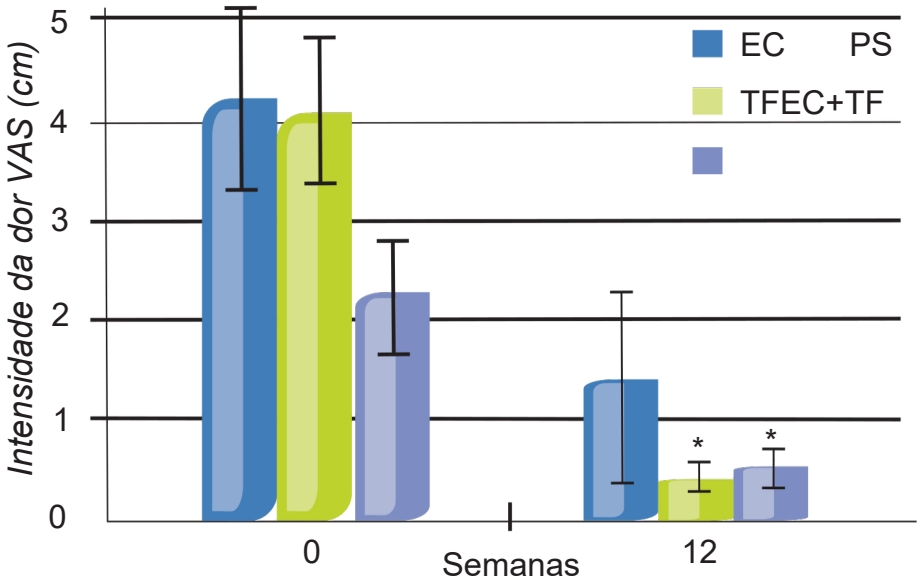
Final ø=0.60 cm

Tendofit® favorece a recuperação da estruturado tendão (redução da espessura do tendão, recuperação da organização normal do colágeno e diminuição da neovascularização)

Arquer et al. Apunts Medicina de l'Esport 2014

Evidências científicas

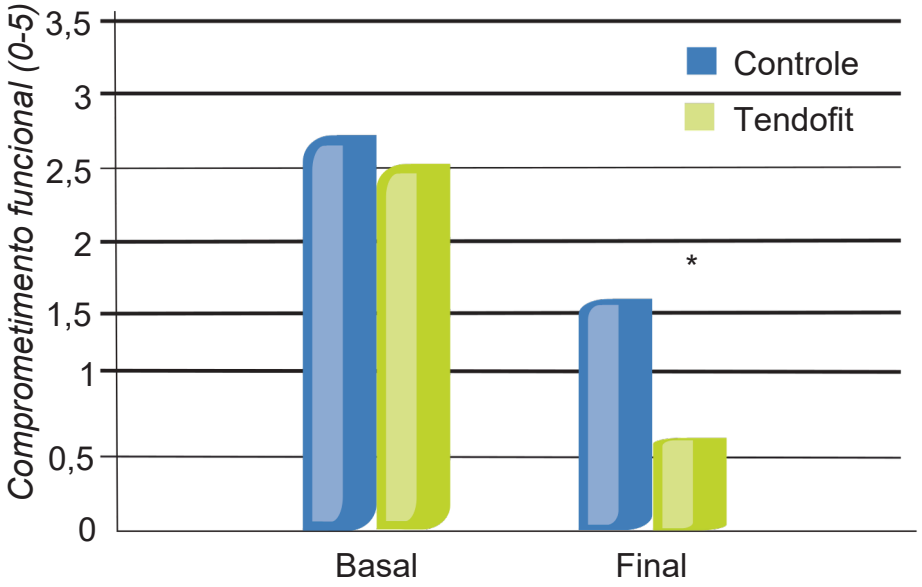
Efeito do alívio da dor



TENDOFIT® combinado com fisioterapia, seja treino excêntrico (EC) ou alongamento passivo (PS), proporciona um benefício adicional em termos de alívio da dor comparado com treino excêntrico sozinho (*P<0.05)

Evidências científicas

Melhora da função do tendões



TENDOFIT® melhora a função do tendão segundo avaliação fisioterapêutica (*p<0.05)

Benefícios

- Produto inovador para saúde e recuperação dos tendões.
- Alternativa terapêutica com ativos estudados.
- Segurança e eficácia comprovadas.
- Pesquisado e desenvolvido pela Bioiberica, líder mundial em saúde das articulações.

Estudos cientificos

Tendões possuem capacidade limitada para auto-reparo devido à baixa densidade e atividade mitótica dos tenócitos.

Citocinas pró-inflamatórias, como interleucina-1ß (IL-1ß) foram identificadas como os principais iniciadores de tendinopatias, estimulando a inflamação, apoptose e degradação da matriz extracelular (MEC).

O objetivo deste estudo foi avaliar o potencial de **Tendofit®** que contém mucopolissacarídeos, colágeno e vitamina C, em modelo in vitro de inflamação do tendão.

Os efeitos do **Tendofit®** foram estudados em culturas primárias de tenócitos humanos tratado com IL-1ß por até 72 h. Expressão de colágeno tipo I, integrina ß1, ciclooxigenase-2 (COX-2), caspase-3 e metaloproteinase de matriz-1 (MMP-1) foram monitorados por western blotting. Os efeitos de **Tendofit®** na expressão, fosforilação e translocação nuclear de componentes protéicos da NF também foram avaliados.

O sistema κB foi estudado por western blotting e imunofluorescência respectivamente. Tratamento de tenócitos com **Tendofit®** suprimiram a indução de IL-1ß Ativação de NF-kB e translocação nuclear p65. Estes eventos foram correlacionados com regulação negativa de alvos NF-κB incluindo COX-2, MMP-1 e caspase-3 ativada. **Tendofit®** também reverteu o downregulation induzido por IL-1ß de colágeno tipo I e receptor da integrina ß1 expressão. Esses resultados indicam que o **Tendofit ®** apresenta potencial nutracêutico como agente anti-inflamatório no tratamento de tendinopatia pela supressão de NF-κB pelas vias de sinalização catabólicas mediadas por IL-1ß em tenócitos.

Anti-inflammatory and anti-catabolic effects of TENDOACTIVE® on human tenocytes in vitro M. Shakibaei1, C. Buhrmann1 and A. Mobasheri2 1Musculoskeletal Research Group, Institute of Anatomy, Ludwig-Maximilian-University Munich, Munich, Germany and 2Musculoskeletal Research Group, School of Veterinary Medicine and Science, Faculty of Medicine and Health Sciences, University of Nottingham, Sutton Bonington, United Kingdom

EFICÁCIA DO TRATAMENTO DA TENDINITE E FASCITE PLANTAR COM TENDOFIT®

Objetivo

Avaliar a eficácia da administração de **Tendofit ®** no tratamento de diferentes tendinopatias: epicondilite, tendinopatia supra-espinhal, tendinopatia de Aquiles e fascite plantar.

Métodos

80 pacientes foram aleatoriamente designados para um grupo de estudo (n = 10) ou grupo controle (n = 10).

Durante 3 meses todos os pacientes receberam entre 20 e 30 sessões de reabilitação. Além disso, o grupo de estudo recebeu **Tendofit®** .Dor, pesquisa de qualidade de vida SF36 e avaliação funcional foram avaliados antes e 1, 2 e 3 meses após o tratamento.

Resultados
O grupo de estudo apresentou uma redução significativa da dor (P <0,05) em todos os subgrupos, exceto no grupo epicondilite.

A redução da dor foi associada a uma melhora de pelo menos uma subescala SF36 em cada subgrupo (P <0,05).

No final do tratamento uma melhora significativa na avaliação funcional pelo fisioterapeuta foi relatada para todas as tendinopatias (P <0,05).

Conclusões
Tendofit® para o tratamento de tendinopatias e fascite plantar é seguro e eficaz, levando a uma redução significativa da dor e melhorando as propriedades biomecânicas da articulação, sem efeitos adversos.

F. Nadal1, T. Bové2, D. Sanchís3, D. Martinez-Puig4
1Clínica Sagrada Família, Barcelona, Espanha; 2Futbol Club Barcelona, Barcelona, Espanha; 3Ctr. de Fisioterapia Toni Bové, Barcelona, Espanha; 4Bioiberica S.A., Palafolls, Espanha

ESTUDO EFICÁCIA E SEGURANÇA DE TENDOFIT® Tendinopatia, acompanhada de mudanças estruturais ao tendão, é uma lesão esportiva comum. O objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia e segurança de **Tendofit** ® na evolução clínica e estrutural de tendinopatias do tendão de Aquiles, tendão patelar e tendão do epicôndilo lateral no cotovelo.

Estudo multicêntrico, aberto, prospectivo, fase exploratória iv foi realizado. Um total de 98 pacientes com tendinopatias (32 de Aquiles, 32 patelar e 34 epicondilares laterais), receberam uma dose diária de **Tendofit®** por 90 dias consecutivos. Todo mês, dor em repouso e dor em atividade foram avaliados usando uma escala visual analógica (VAS).

A função foi avaliada usando os questionários VISA-A, VISA-P e PRTEE, e o tendão afetado foi avaliado por ultrassom.

Resultados Observou-se redução significativa da dor tanto em repouso quanto em atividade entre a primeira visita de controle (dia 30) e o final do estudo (dia 90) para todos os três tipos de tendinopatias. Assim, uma melhoria de 38% no VISA- A, 46% no VISA-P e 77% no PRTEE foi observado no dia 90 (P <0,001). Da mesma forma, uma diminuição de 12% na espessura do tendão de Aquiles, uma diminuição de 10% no tendão patelar e uma diminuição de 20% tendão do epicôndilo lateral foi observado (P <0,05).

Conclusões
Os resultados deste estudo demonstraram que a administração de **Tendofit®** é segura e eficaz para melhorar os sintomas clínicos e a evolução estrutural das tendinopatias dos tendões de Aquiles, patela e epicôndilo lateral.

The efficacy and safety of oral mucopolysaccharide, type i collagen and vitamin C treatment in tendinopathy patients Andreu Arquera , Miquel Garcíab, José Antonio Lauciricac , Marta Riusd, Marian Blàviae, Jaume Fontserèf , Carlos Hernándezg , Jordi Boludah, Tomislav Kranjceci , Ana de la Torrej , Gilberto Díazk , Karin Freitagl , José M. Villalónm, Jaime Baselgan, Pedro Hernándezn, José Gonzalezo , Guillermo Rodríguezo , Horacio Rodríguezp, Juan María Alarcónp, Carlos T. Simorteq, Isaac Vicenter , Montserrat Cabanasr , Pablo Ramírezr , Daniel Martínez Puigr,*